

Entretiens
Médecine Générale

Dr.KHERBA_N

Sommaire :

Crise d'asthme

Bronchiolite

Décompensation de BPCO

Covid_19

PFLA

Épistaxis

Laryngite

Oreillons

Rhinite allergique

Pharyngite

Sinusite

Goutte

RAA

Arrêt Cardio respiratoire

Embolie pulmonaire

IDM

OAP

Pic HTA

Infection urinaire

HTA gravidique

Prééclampsie

Acidocétose diabétique

Hyperglycémie

Pied diabétique

Hypoglycémie

Coma hypoglycémique

AVC

Attaque de panique

Convulsion

Coma

DNV

Méningite

Paralysie faciale périphérique

Colique hépatique

Colique néphrétique

Crise hémorroïdaire

Colopathies fonctionnelles

Diarrhées aiguës

Brûlures

Cellulite

Érysipèle

Gale

Œdème de Quincke

Morsure d'un animal

Piqûres du scorpion

Morsure du serpent

Urticaire

Varicelle

Zona

Polytraumatisme

Vertiges aigus

PNA

Anémie ferriprive

Ictère néonatale

Gastroentérite

Appendicite

Angiocholite

Cholécystite

Pancréatite

Occlusion intestinale aigue

Intoxication alimentaire

Ingestion de caustique

Oxyurose

Etats de choc

Choc Anaphylactique

Fièvre

Conjonctivites

Déshydratation

Calendrier vaccinal

Maladies à déclaration obligatoire

Maladies professionnelles

Score de Glasgow

Score de Silverman

Score d'APGAR

Types des certificats médicaux

Pathologies à dépister au milieu scolaire

Diabète

Leishmaniose

Paludisme

Effets secondaires des CTC

Différence entre EPH et EPSP

Complications de décubitus dorsal

Différence entre rougeole et rubéole

Contre indications de PL

Classification de fracture du coude

Signes d'HIC

Biologie de fièvre typhoïde

Allergie aux protéines de lait de vache

Œil rouge

Brucellose

Maladie coéliquue

Dissection aortique

Menace d'avortement

Menace d'accouchement prématuré MAP

FDR du cancer du seins

FDR du cancer du col utérin

Éclampsie

HELLP syndrome

ATB contre indiqués chez la femme enceinte

Causes des hémorragies de T1 et T3

Hémorragies de délivrance

Rupture prématurée des membranes RPM

Examen de nouveau né

Indications de césarienne

Crise d'asthme

● Dyspnée expiratoire + râles sibilants

Symptômes : Toux, sifflement, essoufflement, tout âge..

✓ CAT :

- Position demi assise
- Scope/VVP (voie veineuse périphérique)
- TA/T°/SaO₂/FC/FR
- Bilan :
- FNS/CRP/VS
- TLT(Pneumonie)

- Inj de CTC : Solumedrol 40mg ou HHC 200mg en IV

- Des séances de Nébulisation 03 de 20 min d'intervalle : 1cc Salbutamol + 3cc SSI

- Si pas de réponse 1 séance/1h + 0.5mg Atrovant Si non Sulfate de Mg 1g ou 1amp diluée dans 100cc de SG 5% en 15min

- Si pas de réponse avis pneumologie !!

- Crise modérée :

- 1 séance/6h

- Inj CTC/8h

- Crise sévère ou pause respiratoire :

- ☐ Avis réa

- Si non Salbutamol en IV + Sulfate de Mg en 15min

- ☐ Evacuation réa ou Pneumo !!

- Enfant :
- 2 séances d'aérosol :
- Salbutamol 0.03cc/kg dans 4cc de SSI9%
- Si pas de réponse : inj Solumedrol 2mg/kg en IM
- Max 6 séances d'aérosol

- ✓ Traitement de sortie :
- Ventoline + CTC

Bronchiolite

● Dyspnée expiratoire + râles sibilants + Toux asmathéforme, sifflement, fièvre..

<2ans : 1^{ère} épisode => Bronchiolite

2^{ème} épisode ou >2ans : Début d'asthme

✓ CAT :

■ Séance de Nébulisation : 0.03cc Salbutamol + 3cc SSI

■ Si non réponse : 2^{ème} ...3^{ème} + CTC
(Celestene/Solumedrol/HHC/Dexa)

🏠 Hospitalisation :

■ 3 séances et non réponse

■ Age <3mois ou sévère

■ Malnutrition, Cardiopathie..

- Prise/2h de FC/FR/SaO₂
- O₂ thérapie
- Arrêt de l'alimentation orale
- Aspiration/4h
- Séance de Nébulisation/6h
- Diurèse/24h
- Réhydratation
- Bilan : Ionogramme
- ECBU
- TLT

☒ Traitement de sortie :

- Bonne hydratation+++
- Fractionner les tétés
- Désobstruction nasale au SSI/2h
- Paracétamol: 15mg/kg 4/j
- ⊖ Antitussifs déconseillés

Décompensation aiguë de BPCO

● Exacerbation aiguë des symptômes respiratoires : Toux, dyspnée, expectorations
Respiration sifflante

✓ CAT :

- Scope/VVP
- Gaz du sang avant O2 et 1h après
- O2 thérapie à faible débit
- Solumedrol 1_2mg/6h en IV
- Nébulisation Salbutamol 5mg + 5cc SSI

⊖ Si non réponse :

- Nébulisation 0.25mg Atrovent
- Si expectorations purulentes=> ATB
(Amoxicilline ou Augmentin)

- Bilan :
- Ionogramme
- TLT
- ECG
- Si suspicion d'embolie pulmonaire :
- Troponines/DDIMÈRE/Angioscanner

Covid_19

● Symptômes : Fièvre, Toux, myalgies, dyspnée, perte de goût et odeur, cas similaire..

FDR : HTA/Cardiopathie/Diabétique/âge =>

Hospitalisation si non : Traitement Ambulatoire

✓ CAT :

🏠 Si Hospitalisation :

- O2 : dépend de SaO2
- ATB : si fièvre >5j, Toux purulente, CRP↑
- Anticoagulants
- Bilan

PFLA

● Symptômes : Fièvre, sueurs nocturnes, douleur thoracique, Toux sèche puis purulente, dyspnée syndrome de condensation, pas de signes ORL.

■ Rx : Opacité dense, homogène, systématisée, segmentaire ou lobaire voire atteinte de tout le poumon, bronchogramme aérique.

■ Auscultation : Râles crépitants

■ Bilan : FNS/CRP/Procalcitonine

✓ Traitement :

■ Amoxicilline si non Clarithromycine ou Zeclar

■ Doliprane

■ +/- Antitussif

→ Contrôle radio clinique 48_72h

Épistaxis

● Hémorragie extériorisée par les fosses nasales

- Bilan d'hémostase avant tout :
- FNS/TP/TCK
- Prise de TA
- Si chronique → Avis ORL
- Méchage nasale : tête surélevée pencher en avant puis compression bidigitalique pdt 10min
- Dycinone en IV

Laryngite

● Symptômes : Dyspnée inspiratoire + râles sibilants + voie rauque

Toux, fièvre, Tirage, cornage, cyanose, stridor

⚠ Abaisse langue et décubitus dorsal sont Cl risque d'épiglottite.

✓ CAT :

■ Inj CTC : Dexta 0.5mg/kg en IV ou IM

Ou Prednisone 1_2mg/kg en IV

■ Si pas de réponse : renouveler inj

■ Si réponse : CTC par VO + traitement symptomatique

■ Si forme grave (détresse respiratoire) =>
Hospitalisation

■ Nébulisation Adrénaline 1cc dans 3cc SSI
20min inj Dexta 0.5mg/kg en IV

■ Si pas de réponse 0.4mg en IM

■ Après 1h si pas de réponse : Nébulisation

■ Adrénaline 1cc + Dexta 2cc + 3cc SSI 20min
Ou Solumedrol inj 1mg/kg

■ Si réponse toujours : Traitement de sortie
ATB + CTC

Oreillons

● Tuméfaction uni puis bilatérale + Douleur (avaler et mâcher) + Fièvre

✓ CAT :

- Isolement et éviction scolaire
- Repos/compresses chaudes
- Traitement symptomatique
- +/- ATB pour prévenir la surinfection
- CTC et AINS sont CI

Rhinite allergique

● Picotements dans le nez, éternuements, écoulement nasal bilatéral clair, gonflement et larmolement des yeux, pas de fièvre.

✓ CTC + Antihistaminique

Pharyngite

● Symptômes : Maux de gorge, douleur de déglutition, sécheresse de gorge.

✓ Traitement symptomatique

Sinusite aigue

● Inflammation des sinus, des cavités osseuses du crâne, fièvre, céphalées, obstruction nasale.

Douleur à la palpation exagérée en poste penchée en avant, écoulement purulent uni ou bilatéral poster

Notion de Rhinite allergique

- Diagnostic : Rx de massif facial
- Confirmer par TDM

✓ CAT :

- Perfalgan 1flac en 15min

Ou Clofenal 1amp en IM

Ou Tamgésic 1/2amp

- O2 thérapie

✓ Traitement de sortie :

1 CTC

2 Antihistaminique

3 Antalgique

4 ATB si fièvre ou persistance des symptômes
« Amoxicilline »

Goutte

● Maladie chronique liée au métabolisme de l'acide urique => Monoarthrite aiguë

■ Diagnostic : Radio clinique confirmer par la biologie => Dosage de l'acide urique.

■ Si Radio et bio (-) => Test à la Clochicine

■ Echographie

✓ Traitement de Crise :

■ Immobiliser l'articulation

■ Poche de glace

■ Régime alimentaire

1 Clochicine

2 Doliprane

3 AINS/CTC

→ Surveillance tout 3mois par le dosage de AU

Normal <60mg

RAA

● Maladie inflammatoire multi-systémique

Une complication non suppurée d'une pharyngite non traitée, due au strepto

Polyarthrite migratrice, cardite, fièvre

Chorée de Sydenham, érythème marginé de Besnier

- Âge 5_15ans

- Bilan : FNS/CRP/VS

- ASLO : >400UI

- ✓ CAT :

- Repos

- 1 Peni G si allergie : Macrolide

- 2 CTC

- Toute angine strepto doit être traitée par Extencilline inj en IM

- Si présence des critères ou ASLO $\nearrow$ ou Antidnas $\nearrow$: Extencilline/21j 3inj

DIAGNOSTIC Les critères de JONES

les critères majeurs : ■ - Cardite (Myocardite, Péricardite, Endocardite ou Pancardite) ■ - Polyarthrite ■ - Chorée ■ - Erythème marginé ■ - Nodosités sous-cutanées de Meynet	les critères mineurs : ■ Fièvre, ■ arthralgie, ■ accélération de VS, hyperleucocytose à polynucléose, allongement de PR,
---	---

Infection streptococcique

- élévation du taux d'ASLO
- prélèvement de gorge

Le diagnostic de RAA repose sur :

- Deux critères majeurs **2M** + la preuve **1s** positif
- Ou un critère majeur + deux critères mineurs **1M+2m**+la preuve **1s**

Arrêt Cardio respiratoire

Inconscience, pas de respiration

- Abolition du pouls :
- Fémoral et carotidien => adulte
- Brachial => Nourrisson

✓ CAT :

- Position dorsale
- Libérer les VAS
- Si absence de traumatisme du rachis : tête en hyperextension
- Massage cardiaque : 100_120/min
- 2 insufflations pour 30 compressions
- Adrénaline :
- Adulte=> 1mg/3min en IVD
- Enfant=> 0.01mg/kg

Embolie pulmonaire

● Symptômes : Syncope, lipothymie, tachycardie, douleur angineuse, pouls paradoxal, cyanose..

Etat de choc : marbrures, collapsus

Hypoxie sévère $\text{PaO}_2 < 60\%$, Acidose

Troubles de repolarisation

ATCD de TVP, immobilisation, Néo, grossesse

Post op...

■ Dosage des DDIMÈRES=> Angioscanner => Échodoppler

■ ECG/TLT

✓ CAT :

■ Position demi assise/VVP

■ O₂ thérapie à fort débit

■ Remplissage : Noradrénaline/Dobutrex

■ Anticoagulants

- EP + état de choc : Thrombolyse
- Si échec : Embolectomie chirurgicale

IDM

● Douleur thoracique constructive irradie vers le membre super gauche/cou/menton.

Atypique : épigastalgies, HypoTA +++

Pâleur, sueurs, cyanose, agitation, panique, détresse respiratoire, Vomissements..

■ ECG chaque 10min : Sus décalage de ST

✓ CAT :

🏠 Hospitalisation

■ O2 thérapie/VVP

■ TA/Dextro

■ Bilan

■ Soulager la douleur :

■ 1flc Perfalgan en IVD

■ Aspegic + Plavix + Lovenox

■ Si St (-) : Dosage des Troponines.

OAP

● Douleur thoracique, dyspnée, détresse respiratoire, cyanose, difficulté de parler, HypoTA, sueurs, fièvre, Toux sèche, glaires blanchâtres, râles crépitants +++

Ne supporte pas la position prolongée.

Presque une crise d'asthme mais pas d'ATCP d'asthme même en présence des sibilants.

- Rx : Ailes du papillon 🦋
- Sujet âgé >50ans, cardiopathie, hypertendu.

✓ CAT :

- Position demi assise
- O2 thérapie/VVP
- TA/T°/Dextro
- ECG
- Bilan

- Si $TA > 110 \text{ mmHg} \Rightarrow$ Lasilix 40mg en IVD/20min

- Si non réponse : Avis réa

- Si IR : 120mg Lasilix

- Si $TA < 110 \text{ mmHg} \Rightarrow$ O2 thérapie/VVP

- Avis réa : Dobutrex

- Si $TA \nearrow$ dans ce cas $\Rightarrow$ Lasilix

Pic ou poussée Hypertensive

● Pic ou poussée Hypertensive => pas d'atteinte viscérale

Urgence Hypertensive => présence d'une atteinte viscérale

Céphalées, anxiété, Vertiges, confusion, douleur thoracique, douleur à la nuque, palpitations, acouphènes, bourdonnement d'oreilles, épistaxis, dyspnée, flou visuel, Insomnie, nausées, Vomissements

■ PAS > 180/170 mmHg

■ PAD > 120/110 mmHg

⊖ Eliminer l'urgence :

AVC/OAP/IDM/Dissection

aortique/Prééclampsie/Retinopathies

Hypertensives..

✓ CAT :

- Prise TA/FC/FR/SaO₂
- O₂ thérapie/VVP
- 1/2 amp Mg dans 250cc SG 5 %

- Après 30min si pas de réponse :
- Captopril cp 25mg 1cp... 2^{ème} cp...3^{ème} cp
- Si non Loxen ini 1cc dans 3cc SG 5%
... 2cc... 10cc/24h en IVD.
- Traitement : Amlor ou Lopril..
- Profil TA + RHD : Régime 1/2 sel, activités physiques...

Urgence Hypertensive

● Clinique :

- PAS > 210mmhg PAD > 100mmhg

- Encéphalopathie hypertensive :

Céphalée, Coma, Convulsion, troubles visuels de vigilance..

- Troubles digestifs : nausées/vomissements..

- Etiologies :

Hypertension maligne, arrêt du traitement, stress, alcool, AINS, CTC, IDM, éclampsie, Dissection aortique...

✓ CAT :

- Hospitalisation

- VVP

- TA/Monitoring

- Bilan biologique
- Rx thoracique
- ECG
- TDM cérébrale avant traitement

⊖ Ne pas ↗ la TA plus 25% risque d'œdème cérébral

- Loxen 1cc (1mg) dilué dans 1cc SG5% IVL pdt 3min
- Si TA ↗ : même schéma + ECG
- Si TA ↗↗ : Loxen 1g 1cc en IVL tt les 10min suivi par 5mg/h Loxen en IVSE (2amp ramené à 48cc SG5%, débit =5cc/h à ↗ par palier de 2.5cc mg/h chaque 15min max 15cc mg/h)
- Réhydratation IV sérum 1000ml en 2h
- Traitement spécifique de la souffrance
- Bilan complet + profil TA=> Avis cardio

Infection urinaire

● Symptômes : Brûlures mictionnelles+++

Dysurie, pollakurie, Hématurie, douleurs abdominales, Apyrécie, BEG

■ Labstix : sang/protéine/Nitrites/Leucocytes

■ CU : Nitrites=>ECBU + AntibioGramme

+/_ Echographie chez l'enfant

HTA gravidique

● Grossesse > 20SA

- TA > 140/90 mmHg sans protéinuries
- Repos puis une prise de TA
- Bilan complet

- Si Toujours TA $\nearrow$:
- 1cc Loxen dans 3cc de SSI + CU
- Si réponse : profil TA + Bilan HTA
- Protéinuries des 24h
- Surveillance fœtale

Prééclampsie

● TA $\nearrow$ + Protéinurie $>3\text{g}/24\text{h}$ Ou $>$ à (++) CU

○ Edème + HTA + Protéinurie +++

🏠 Rechercher :

- OMI

- $\nearrow$ Urée : $350\text{Umol/l} \Rightarrow$

Début d'IR et une souffrance placentaire

- Facteurs hépatiques

- Thrombopénie 150.000

- RCIU retard de croissance.

☑ CAT : pré éclampsie sans crise (que les signes)

- O₂ thérapie/VVP

- Si pas de signes neurologiques et TA pas très

$\nearrow$: Aldomet per os

- Si non ajouter Nicardipine 1cp/12h

Ou 1cc Loxen dilué au SSI en IVD

- Bilan Complet
- Surveillance des paramètres
- Si crise => Valium

☞ Avis gynécologie

⊖ Complication :

- Hellp syndrome : diagnostic biologique
- Hémolyse
- ASAT/ALAT ↗
- Thrombopénie

Pré_éclampsie sévère

● Un ou plusieurs des signes :

- TA > 16/11
- Douleur pelvienne + vomissements
- Éclampsie ou troubles neurologiques :
céphalée + troubles visuels.
- Atteinte rénale :
 - Oligurie < 500ml/24h
 - Protéinurie des 24h > 3,5g/l
 - Creat > 100Umol/l
- OAP ou Hellp syndrome :
 - Thrombopénie < 100.000
 - Cytolyse hépatique 3×normal

Hospitalisation

- Surveillance clinique : TA/30min, diurèse, conscience, dyspnée, aggravation des signes neurologiques..
- Surveillance biologique: /24h
- Bilirubine/haptoglobine/LDH/CPK/créat/urée/albuminurie/Ionogramme

CAT :

- O2/VVP/Sondage
- Si HTA sévère : bolus IV 0.5_1mg de Nicardipine but : PAS<160

Puis administration continue en IV Nicardipine et Labetalol dans le SG

- Remplissage vasculaire
- Si diurèse <600ml/h perfusion en 1h des solutés cristalloïdes 500_750ml
- Furosémide 20_40mg en IV

Acidocétose diabétique

- Gly > 2g/l
 - Glucosurie ++
 - Cétonurie +++
 - Hyperglycémie : fatigue, polyurie, soif intense et dyspnée
 - Hypercétonurie : douleur abdominale, Vomissements, odeur acétonurique de l'haleine et troubles de conscience..
 - Acidose : respiration de Kussmull, HypoTA
 - Déshydratation
-
- ✓ CAT:
 - O₂/PLS
 - TA/DEXTRO/T°/Labstix => CC+++
 - TLT(foyer)
 - ECG

- Bilan
- ECBU
- Ionogramme

✓ **Traitement : Réhydratation + Insulinothérapie**

- Réhydratation :
 - 1l en 1h => 1l ssi 2flacons 5% chaque 1/2h
 - 1l en 2h => 1l ssi 1h
 - 1l en 3h => 1l ssi 1h30min
 - 1l en 4h => 1l ssi 2h
- Supplémentation en KCl et NaCl dépend de l'ionogramme.
- Si fièvre => Perfalgan/8h
- Si infection => Claforan/12h
- Insulinothérapie : en IV jusqu'à (-) des CC
50cc SSI + 0.1Ui/kg/h
- Si CC(-) passe en sc/h
10Ui IO en sc/h

- $\text{Gly} > 2.5 \Rightarrow \text{SG} 9\%$
- $1.5 < \text{Gly} < 2.5 \Rightarrow \text{SG} 5\%$
- $\text{Gly} < 1.5 \Rightarrow \text{SG} 10\%$

Hyperglycémie

Avec ou sans cétose

- Sujet diabétique : mauvaise prise du traitement ou infection
- Sujet non diabétique : Vertige, asthénie..

✓ CAT :

- Dextro $>2.5\text{g/l}$
- Labstix : cc(-)
- Insulinothérapie $\Rightarrow 10\text{Ui en sc/h}$
- Si : CC(+) $\Rightarrow 10\text{Ui en IV/h jusqu'à (-) des CC}$
- Dès (-) $\Rightarrow 5\text{Ui en IVD et } 5\text{Ui en sc (hiatus)}$

Puis après 6h : 10Ui/6h en sc

+ Réhydratation $\Rightarrow$ boire 1.5l eau dans 2h

■ Perfusion SSI :

■ 1l pdt 1h puis 1l pdt 2h puis 1l pdt 3h puis 3l pdt 6h

■ 1amp de K dans le flacon à partir de la 4^{ème} h

■ TLT : Rechercher un foyer

Labstix/ECBU

■ ECG : si Hypokaliémie corriger avant

Insulinothérapie

■ Surveillance de glycémie /30min, Labstix/3h, Ionogramme/3h

■ Si : FDR + découverte de glycémie $\nearrow$:

Hospitalisation

■ Si : CC(+) + glycémie $\nearrow$:Hospitalisation

⊖ Ne Libérer jamais un patient sans (-) des CC

Pied diabétique

✓ Traitement :

1 Pyostacine cp 500mg 2cp 2/j

2 Flagyl cp 500mg 1cp 3/j

Ou

1 Lexin cp 1g 1cp 3/j pdt 7j

Ou Cefacet si présence du pus ou infecté

2 Fucidine pmd 1app 3/j

Après lavage au SSI

- Bilan complet
- Rx du pied
- Echodoppler
- Soins locaux 1/2j

Hypoglycémie

Coma Hypoglycémique

● Gly < 0.5g/l ou < 2.8mmol/m

Troubles de conscience, asthénie, sueurs, faim, Tremblement, tachycardie, céphalée, Vertige, acouphènes, Troubles visuels, déficit moteur..

✓ CAT :

■ O₂/VVP

■ Dextro/TA

■ Si conscient=> Administrer en urgence de boissons sucrés.. Contrôle 15_30min

■ Si inconscient=>

10cc de SG 30% en 15min

Puis 200cc de SG 5% en 30min

- Adapter les dose de l'insuline :
 - Si on trouve la cause de l'hypoglycémie => pas d'adaptation on traite la cause.
 - Si on trouve pas une cause=> ↘ la dose

 - Chez le diabétique risque de rechute ou si voie d'abord difficile=> 1_2mg 1amp Glucagon en IM ou sc
 - 1amp 1mg >25kg
 - 1/2amp 0.5mg <25kg
- Après 20min si gly ↘ => 2^{ème} amp

⊖ Glucagon est CI chez un Sujet sous sulfamides Hypoglycémiants ou alcoolique ou DT2

Hypoglycémie

● Enfant diabétique :

✓ Si conscient :

- Dextro
- 5g du sucre pour 20kg sans dépasser 3 morceaux qq le poids.
- 15min puis donner du sucre lent
- Dextro 15_30min après.

✓ si inconscient ou avec des crises convulsives :

- Rien par VO
- SG10% : 10ml/kg bolus
- Puis 5ml/kg pour maintenir
- Glucagon en IM :
- >25kg : 1amp 1mg
- <25kg : 1/2amp 0.5mg

- Si pas de réponse : inj SG

- SG10% : 2_4cc/kg en IVD

⊖ SG30% : à Éviter le max

0.5_1cc/kg en IVD

- Arrêt l'inj dès la reprise du conscience

15min => sucre lent

- Dextro 15_30min après

AVC

● Troubles neurologiques: aphasie, dysarthrie, céphalée (drapeau rouge), flou visuel, paralysie faciale périphérique ou centrale, déficit moteur, hémiparésie ou hémiplégie.

Diagnostic différentiel : Crise épileptique=> perte des urines, morsure de la langue..

✓ CAT:

■ O₂/VVP

■ Dextro/T°

■ TA > 18/10 ne pas ☐ TA à faire une TDM

sauf si TA 220/120 on ☐ progressivement

■ ECG pour éliminer IDM

☐ Evacuation pour un scanner cérébral

20%: hyperdensité=> AVC hémorragique

☐ Evacuation Neurochirurgie

80%: hypodensité => AVC ischémique

☞ Hospitalisation au moins 24_48h

- Mannitol 100cc/8h

⊖ SGI est CI risque d'œdème cérébral

- Matelas antiescarres

- O2 3l/min sauf si SaO2 correcte

- Réhydratation SSI/8h 1flc

- Si fièvre: Perfalgan/8h 1flc

- Si Gly>2g: Insulinothérapie 10UI en sc

- Si TA>220/120=>1cc Loxen dilué SG5%

- ECG: si Troubles de rythme =>Avis cardiologie

☑ Traitement :

- SOMAZINA amp 500mg en IVL 250cc SSI

1amp/j

Relais per os 40gtt/min 2ml 3/j

- Aspegic st 100mg 1st/j
- Azantac
- Contrôle TDM après 48h
- Bilan
- Consulter  Cardio/Neuro/Kinésithérapie

Attaque de panique

● Sensation de peur intense, brutale et transitoire. Sueurs, palpitations, impression d'étouffer, douleurs à la poitrine, nausées, picotements..

Rechercher : Hypoglycémie, IDM, Hyperthyroïdie, Anémie, HTA

✓ CAT :

- Repos/O2/VVP/Scope
- Dextro
- ECG

🏠 Mg 1amp +/- Primperan dans 300cc SG IVL

Convulsion

● Interrogatoire : Grossesse, VIH, Épilepsie, néoplasie, traumatisme, Ethylisme, traitement diurétiques, Hypoglycémie, Méningite, AVC..

- Si 1^{ère} Crise => TDM, EEG, ECG
- Convulsion + Fièvre => TDM+PL
- Convulsion + confusion > 24h => Hospitalisation + TDM + EEG
- Intoxication médicamenteuse => Dosage.

✓ CAT: Adulte

- TA/Dextro
- Bilan
- PLS/O2 thérapie
- Valium 0.5mg/kg (poids/2) 1 amp 10mg (2cc) dans 10 cc de SSI 9% en IVL sans dépasser 2amp (max 1amp 10cc)
- 20min: si pas de réponse : 2ème amp Valium

- Gardenal dose de charge 15mg/kg sur 2 fois dans 500cc de SG à flot en 30_45min

- Si réponse : dose d'entretien 5mg/kg dans 500cc SG gtt à gtt passer en 24h

Sans dépasser 1g

⊖ État de mal convulsif:

- Valium 1amp diluée Ou 0.1mg/kg/j en IVL

- Gardenal 10mg/kg/j

Convulsion

● Enfant : inconscient, cyanose..

✓ CAT:

■ PLS/O₂ 4L/min si masque 8L/min

■ Dextro/T°/VVP

■ Valium 0.5mg/kg en intra rectale IR

Max: 10mg/j

■ 2_5min si pas réponse:

■ 2ème Valium 0.5mg/kg en IR

■ 3ème Valium 0.5mg/kg en IR

■ 2_5min si pas de réponse:

■ Gardenal 2mg/kg Max 20mg

dans 150mg SG5% ou 60cc SSI en IVL 20min

■ Rechercher la cause :

■ Fièvre:

=> foyer si infection : Augmentin 1ddp 2/j

=> pas de foyer: TLT + ECBU

■ Si ECBU(+) => Oroken 1ddp 2/j pdt 7j

■ Si traumatisme => Scanner

■ Si apyrétique + crises => Avis neurologie

Depakine 10mg/kg/j pdt 5_7j

■ Si Pyrétique : PL+EEG

■ Si crises complexes TDM+IRM

⊖ Valium est CI chez NNE <2mois

Coma

 En urgence :

- PLS/O2/perfusion SSI

- TA/T°/VVP/Dextro

- Bilan : Ionogramme

- Si : Traumatisme

- Signes de focalisation ☐ Avis neurologie

- Pas de signes de focalisation ☐ TDM

- Si : pas Traumatisme :

- CO=> O2 : 8l/min

- Médicaments=> O2 + 100mg HHC en iv

- Hypoglycémie=> 50cc SG30%

Puis 1flc SG10% puis 1flc SG5%

1flc/8h

■ Restauration de conscience => alimentation (glucides/lipides) pour éviter les rechute

⊖ Devant tout coma, il faut évoquer l'hypoglycémie comme cause (l'étiologie la plus fréquente)

DNV

● Dystonie neurovégétative est un trouble du passage de l'excitation nerveuse au niveau du nerf vague.

Fatigue intense, soif excessive (polydipsie), vertige, anxiété, panique, palpitations lentes..

✓ CAT :

- O2 thérapie
- 1amp Primperan en IM
- 1amp Mg diluée dans 250cc SG5% IVL
- Si HTA... on traite cas par cas..

- Prise des constantes si : normal libérer le malade avec :
- Mg cp/sirop/inj

Méningite

⊗ Fièvre, vomissements, cri aigue, refus alimentation, crises convulsives...=> PL

Syndrome infectieux + sd méningé
(Vomissements/photophobie/céphalée)

Raideur de la nuque, signe de Kering et Brudinski.

■ Rechercher les signes de HIC=> TDM+FO

Avant PL

⊖ Contre indications du PL :

- HIC
- Troubles d'hémostase
- Instabilité hémodynamique et respiratoire.

☑ Amoxicilline 2g avant PL

Après on traite selon le germe

Paralysie faciale périphérique

● Touche l'hémiface, impossibilité de fermer les yeux (risque de kératite favorisée par la sécheresse), gonflement de bouche, effacement des rides, pli nasolabial, déviation de bouche.

Post infectieuse+++

■ Si centrale (touche l'étage inférieur, déviation de bouche) ou déficit neuro associé => TDM (masse cérébrale).

■ Si TA ↗ => TDM

■ Si fièvre : pas de foyer => TDM => PL

🏠 En urgence :

■ TA/T°/Dextro

■ Inj CTC : Solumedrol ou HHC

✓ Traitement de sortie : CTC + Neurovit + sérum oculaire

Colique hépatique

● Douleur brutale intense HCD en regard du foie, déclenchée par un repas copieux riche en graisses, irradie vers l'épaule homolatéral, fièvre

- Signe de Murphy +
- Diagnostic différentiel CN qui irradie vers les organes génitaux.

✓ CAT :

- O2/VVP
 - 1amp Spasfon en IVD
- Ou 1 flacon Perfalgan en IV

- Echographie AP
- Bilan
- Traitement symptomatique

 Hospitalisation si :

- Douleur + Fièvre =>Cholécystite
- Douleur + Fièvre + ictère =>Angiocholite
- ATB + Avis Chirurgie en urgence !

- Spasfon/8h
- Perfalgan/8h
- SSI/8h
- Primperan/12h
- ATB :Flagyl 500mg/12h
- Ciprofloxacine 200mg 2/j

Colique néphrétique

● Douleur unilombaire, agitation, pas de position antalgique, insupportable, irradie vers les OGE, pas de fièvre.

Frapper le dos en regard du rein=> déclencher la douleur.

⊖ Restriction hydrique lors du crise

AINS sont CI

🏠 Hospitalisation si :

- Oligo Anurique
- Fébrile 38.5
- Hyperalgique
- Seul rein
- Femme enceinte

✓ CAT : but Soulager la douleur

■ Clofenal 1amp en IM

Ou Voltarene inj 75mg en IM

■ Si pas amélioration :

■ Perfusion 1flacon Perfalgan 1g à flot

■ Labstix : sang+

■ CU/ECBU

■ Échographie

✓ Traitement de sortie :

■ AINS + IPP + Antispasmodique

■ Enfant 🧒 :

■ 1inj Voltarene en IM

■ Échographie AP

■ Bilan rénal

■ ECBU + Antibiogramme

➡ Avis urologie

Crise hémorroïdaire

● Rectosegmoïdoscopie en 1^{er} confirme le diagnostic et élimine une tumeur.

✓ Traitement selon stade :

1 2 => médical

3 => médical ou instrumental

4 => instrumental ou chirurgie

⚠ CAT :

■ 1 amp Voltarene en IM

+ 1 amp Spasfon en IM ou IVD

Ou perfusion 1 flc Perfalgan en IV

■ Bilan : ⚪ de retentissement si saignement

■ FNS/Ferritinémie

■ Régime alimentaire riche en fibres, activités physiques, éviter le debout prolongé, assis, épices, café, thé..

→ Avis gastrologie=> Rectoscopie

Colopathies fonctionnelles

- Diarrhées => Coproparasitologie des selles
- Diarrhées fréquentes => Maladie cœliaque (IgA antiTG)
- Constipation => TSH/FT4/FT3
- Douleur localisée => Echographie abd

 En urgence :

- 1 amp Primperan

Ou 1 amp Sapsfon en IM

☒ Traitement de sortie : symptomatique

- Enfant  :

1 Débridat sirop

2 Spasfon lyoc

Diarrhées aiguës

● ↗ du nombre des selles ...

Étiologies Diabète/Gastroentérite

■ Virales 80% :

Selles aqueuses ni glaires ni sang

+/_ symptômes respiratoire et ORL

■ Bactériennes :

Fièvre, glaires, sanglantes, signes neuro,
douleur abdominale.

■ Coproculture si :

■ Prolongée >5j

■ Déshydratation sévère

■ Terrain : VIH..

✓ CAT :

- Déshydratation $<10\%$ $\Rightarrow$ Ambulatoire
 - Réhydratation orale par SRO
 - <3 mois : poursuit le lait maternel
 - >3 mois : lait habituel ou pauvre en lactose
 - Si Diversification : eau de riz

- Déshydratation $>10\%$ $\Rightarrow$ Hospitalisation
- ATB : si fièvre, syndrome inflammatoire ou glairo sanglants

Brûlures

1^{er} degré : érythème isolé

2^{ème} degré : phlyctène

Superficiel : rose ou hémorragique

Profond : hétérogène, rouge brune ou blanche

3^{ème} degré : Plaie brune ou noire, pas de cloques.

4^{ème} degré :

La totalité de l'épiderme et derme, os, muscles et nerfs sont atteints.

✓ CAT :

■ Réhydratation : 4cc SSI /kg/Sc/j

1 Flammazine pmd 1 app 3/j 1 tube

Avec l'intermédiaire d'un gaz stérile soit directement sur la lésion.

2 Floxapen cp 500mg 1cp 3/j

3 Doliprane 15mg/kg/6h

1^{er} degré => Biafine ou Flammazine pmd

Tulle gras

- Enfant 🧒 : Hospitalisation
- Réhydratation par SRH/6h pdt 48h IVL
- Flammazine et tulle gras
- Cefacet 25_50mg/kg/6h en IVD

Protocole de 7j

■ Traitement de sortie après amélioration : Mebo ou Biafine.

- Soins pour les brûlures :
- Nettoyage au SSI puis appliquer Mebo ou Biafine pmd
- Changement de pansement 1/2j

Cellulite

● Infection du tissu adipeux sous cutané,
Strepto++

Douleur + chaleur + œdème + érythème.

⇒ Echographie des parties molles pour
éliminer une collection abcédée

■ Bilan infectieux : 

■ FNS/CRP

→ Contrôle CRP/48h

⊖ Les AINS sont CI

✓ CAT : Hospitalisation

■ Immobilisation si cellulite de membre super
ou inférieur

1 Cefazoline 1g 4/j

2 Flagyl 500mg 3/j en perf

3 Lovenox 0.4

■ Au niveau de visage :

1 Amoxicilline 50mg/kg/j

2 Flagyl 30mg/kg/j

3 Paracétamol

■ Bain de bouche

→ Avis ORL

■ Si terrain :

■ Pyostacine cp 500mg 2cp 2/j

Ou Fucidine cp 250mg 2cp 3/j

Érysipèle

● Dermohypodermite bactérienne aigue non nécrosante

Zone inflammatoire rouge douloureuse unilatérale de la peau surtout le membre inférieur +++ d'origine strepto+++

Plaque érythémateuse à bordure nets, chaud, fièvre, frissons.

- Penser toujours à la TVP=> signes de Homonas/palper mollet
- Rechercher la porte d'entrée : Intertrigo.

🏠 Critères d'hospitalisation :

- Évolution défavorable après 72h
- Signes généraux importants
- Fébrile ou présence des signes de nécrose
- Terrain : ID .. diabétique

Si non traitement Ambulatoire

✓ Traitement :

- Repos avec surélévation du membre

1 Augmentin 1g 3/j pdt 15j

2 Doliprane cp 1g 1cp 3/j

- Traitement de la porte d'entrée souvent :
Intertrigo

- Mycoster crème 1app 2/j pdt 21j

Ou Pevaryl spray 1app 2/j

- Si allergie : aux Pénicillines

- Pyostacine cp 500mg 2cp 3/j pdt 15j

- Si pas disponible => Rovamycine

⊖ Les AINS sont CI

 Si : Hospitalisation

■ Peni G 5Mui (3_6Mui) dans 250cc de SG5% en IVL 1/j pdt 2j

■ Puis relais par Traitement de sortie :

■ Orapen 1Mui 1cp 2/j pdt 10j

Ou Cefa

+ Lovenox à dose préventive 0.4/24h

■ Bilan :

■ Glycémie

■ Echodoppler

Gale

● Prurit nocturne intense, lésions de grattage, vésiculo pustuleuses, sillon scabieux interdigitale et au niveau du pli du coude, pas de fièvre, Respect le visage.

Nourrisson => palmoplantaire

Cas similaire dans l'entourage..

✓ Traitement : Adulte

■ Traitement de toute la famille !

1 Ascabiol 25% lotion 2flacs appliquer sur tout le corps sauf visage

J1 : Après bain chaud 1^{er} app 10min 2^{ème} app

J2 : 3^{ème} app sans Douche

J3 : Douche

2 Aphtiria poudre ou talc anti gale

Mettez la literie et vêtements dans un sac occlus 72h puis lavez 60°

+/_ Antihistaminique

- Enfant 🧒 : même que la femme enceinte
- Ascabiol lotion 1 seule application de durée <12h
- Après Douche et séchage
- Couper les ongles

Œdème de Quincke

● Gonflement rapide de la peau et des muqueuses au niveau de la tête et du cou + Fièvre + Urticaire.

🏠 En urgence :

■ O₂/TA/T°/VVP

■ 40mg Solumedrol en IVD 1mg/kg

■ Après 1h si pas de réponse => 200mg HHC en IVD

+ 1 amp Phenergan en IM 1_2h

CTC/6h

■ Si dyspnée : 1 séance de Nébulisation :

■ 1cc Adrénaline + 3cc SSI 15 min

■ Si non réponse => Hospitalisation en médecine interne ou avis réa !

✓ Traitement de sortie : Antihistaminique + CTC

Morsure d'un animal

 Proscrire toute suture ou pansement

=>Points de rapprochement après installation du SAR si plaie hémorragique ou profonde.

■ Soins locaux :

■ Nettoyage de la profondeur à l'eau avec savon Marseille puis appliquer une solution à l'alcool iodée.

■ Si Morsure d'un rat pas VAR ni SAR

=>Doxycycline 1/j le soir pdt 5j

200mg :>60kg

100mg :<60kg

⊖ CI chez l'enfant <8ans et femme enceinte

■ Amoxicilline 50mg/kg/j pdt 5j

1 Stade I : Rien

2 Stade II :

- VAR => J1J2J3J4J5J6 en sc periombilical

- Adulte et enfant >5ans=> 2cc

- Enfant=> 1cc (1/2amp)

Puis les rappels en intradermique J11J15

- Adulte et enfant >5ans=>0.25cc en 2 Points différentes, <5ans=>0.1cc

- Rappels J30J90 en ID si grande lésion

3 Stade III :

- VAR + SAR

- SAR : Dose= $(40 \times \text{poids}) / 200$

Un flacon => 5ml

- Une quantité de la dose est infiltrée autour la plaie et le reste en IM Après un test (0.1ml en sc 15min après 0.25ml en sc 15min après :

- Si réaction (-)=>la totalité du reste en IM

■ Si réaction (+) => 0.25ml chaque 15min jusqu'à l'épuisement de la dose.

■ Adulte : Augmentin cp 1g 1cp 2/j pdt 10j

■ Enfant : Augmentin sirop 1ddp 2/j pdt 10j

1- Apprécier la nature de l'agression et ses caractères :

GRADE I	-contact direct avec un animal (la personne l'a touché ou nourri), - léchage de la peau intacte.
GRADE II	. morsure(s) ou griffure(s) sans saignement siégeant ailleurs qu'à la tête, aux extrémités et aux organes génitaux.
GRADE III	▪ morsure(s) ou griffure(s), même sans saignement, siégeant à la face, à la tête, au cou, aux mains, aux pieds aux organes génitaux, ▪ morsure ou griffure unique ou multiple avec saignement ou ayant traversé le derme ▪ morsure(s) par animal sauvage ▪ exposition à une chauve - souris (morsure ou griffure ou manipulation), ▪ léchage ou contamination des muqueuses par la salive, projection de bave sur les muqueuses en particulier les yeux ▪ léchage sur peau lésée.

Piqûre du scorpion

● Stade1 :

- Surveillance pdt 4h :
- O2 10_15min
- SAS 1amp en IM
- Traitement symptomatique.

● Stade2 : Hospitalisation 24h

- Prodaf 1g en IVL
- SAS 1amp en IM
- HTA :Nicardipine
- Convulsion => Gardenal

● Stades3 : Hospitalisation en soin intensif

- PLS /O2 6_10l/min
- Monitoring

- SAS à renouveler après 3h si nécessaire sans dépasser 4amp
- Intubation trachéale
- Dobutamine : 10mg/kg/min
- Enfant 🧒 :
- SAS 1amp indépendant de l'âge.

Classification clinique des Piqûres et Envenimations scorpioniques

Type de la piqure	Classe de la piqure	Manifestations cliniques	%
Piqure blanche	Classe I	Manifestations locales : Douleur, rougeur, sensation de brûlure, Fourmillements ...	91.34
Piqure avec envenimation	Classe II	Manifestations systémiques mineures : (ne mettant pas en jeu le pronostic vital) : hypersudation, fièvre, vomissements, priapisme, HTA, douleur abdominale ...	8.76
Piqure avec envenimation	Classe III	Manifestations systémiques majeures : (mettant en jeu le pronostic vital) : Cardio-vasculaires, respiratoires et neurologiques.	8.76

<https://rea.icu/>

Morsure du serpent

- Immobiliser le membre
- Bandage non serré
- Glace locale
- SAV autour du plaie
- Dose ne dépend pas de l'âge ni de poids

Hospitalisation : Traitement symptomatique

- Si pas de signes généraux :
- Augmentin 2g/j
- Désinfection locale
- Surveillance 24h

- Œdème + signes généraux :
- Solumedrol 40mg en IV
- Prodaf 1g en IVL

- Augmentin 2g/j
- Gentamycine 80mg/j
- SAV 1 amp de 4ml diluée dans 100cc SSI 9%
passé sur 1h
- À répéter chaque 5h jusqu'à disparition des
signes

- Œdème + signes généraux + complications :
- Précédent + Héparine si CIVD

CONDUITE À TENIR DEVANT UN CAS DE MORSURE DE SERPENT

GRADE DE MORSURE	TABLEAU CLINIQUE	CONDUITE À TENIR
GRADE 0: MORSURE SANS ENVENIMATION (MORSURE BLANCHE)	- TRACES DE CROCHETS AU NIVEAU DE LA MORSURE - ABSENCE D' OEDEME OU DE REACTION LOCALE - EN GENERAL INDOLORE	- SURVEILLANCE DE 4 HEURES AUX URGENCES (APPARITION D'OEDEME) - AU- DELA, UNE EVOLUTION VERS GRADE I EST IMPROBABLE. - DESINFECTION LOCALE ET CONTROLE DE LA VACCINATION ANTITETANIQUE
GRADE I: ENVENIMATION MINIME	- OEDEME LOCAL DOULEUREUX - ABSENCE DE SIGNES GENERAUX	- HOSPITALISATION PENDANT AU MOINS 24 HEURES AUX URGENCES. - REEVALUER LA GRADATION TOUTES LES HEURES PENDANT LA PERIODE D'AGGRAVATION MAXIMALE (6 PREMIERES HEURES) - TRACER LE NIVEAU DE L'OEDEME AU FEUTRE SUR LA PEAU. - EXAMENS BIOLOGIQUES À RENOUVELER TOUTES LES 6 HEURES. - TRAITEMENT IDEM AU GRADE 0 ET ANTALGIQUES (EVITER LES SALICYLES).
GRADE II: ENVENIMATION MODEREE	- OEDEME REGIONAL DU MEMBRE ET/OU SYMPTOMES GENERAUX MODERES (HYPOTENSION MODEREE, MALAISE, VOMISSEMENT, DOULEURS ABDOMINALES, DIARRHEES)	- HOSPITALISATION EN REANIMATION. - SERUM ANTIVIPERIN DOIT ETRE ADMINISTRE LE PLUS TOT POSSIBLE, AU MIEUX DANS LES 6 HEURES. - ANTIBIOTHERAPIE DOIT ETRE ENVISAGEE S'IL EXISTE UNE INFECTION OU NECROSE LOCALE.
GRADE III: ENVENIMATION SEVERE	- OEDEME EXTENSIF ATTEIGNANT LE TRONC ET/OU SYMPTOMES GENERAUX SEVERES (HYPOTENSION PROLONGEE, CHOC, REACTION ANAPHYLACTOIDE, ATTEINTES VISCERALES).	- HOSPITALISATION EN REANIMATION. - SERUM ANTIVIPERIN (GRADE II) - CORRECTION RAPIDE DES TROUBLES HEMODYNAMIQUES : EXPANSION VOLEMIQUES, SYMPATHOMIMETIQUES. - TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DES COMPLICATIONS.

NB : Quel bilan effectuer ? à quel moment ?

FNS ; TP ; TCK ; Fibrinogène ; ionogramme sanguin ; urémie ; créatinémie ; CPK ; produits de dégradation de α fibrine

Dès l'apparition des signes d'envenimation locale.

REFERENCES : EMC URGENCES.

Urticaire

● Dermatose inflammatoire marquée par un œdème dermique ou dermo-hypodermique.

Eruption cutanée érythémateuse et papuleuse dont les lésions sont typiquement fugaces , migratrices et prurigineuses.

Contours réguliers, reliefs bombés, tailles différentes.

Fugace=> يـجـو و يـرـو حـو

Migratrice=> يـتـحـر كـو

🏠 En urgence :

■ Phenergan 1amp en IM

✓ Traitement de sortie :

1 Telfast cp 180mg 1cp /j le soir

Ou Xycair 1cp le soir

2 Solupred cp 20mg 2cp/j le matin à jeun 5j

● Enfant 🧒 :

- Si œdème : palpibral ou des lèvres
- HHC 5mg/kg en IVD max 100mg
- Si pas de réponse => Adrénaline !!

<2ans : Primalan sirop 1cac/j le soir

>2ans : Zyrtec gtt 10gtt le soir

>6ans : même que adulte

- Si chronique >6 semaines => Avis dermatologie !

Varicelle

● Maladie infectieuse virale extrêmement contagieuse. Elle est responsable d'une éruption de vésicules sur la peau et les muqueuses, touche le cuir chevelu

- Éviction scolaire 10j
- Bain + couper les angles.

⊖ AINS sont CI

✓ Traitement :

- 1 Hexomédine sol 2app/j
- 2 Doliprane cp 500mg 3/j
- 3 Histagan cp 1cp/j la nuit pdt 5j
- 4 Fucidine pmd

■ Enfant  :

1 Hexomédine ou Eosine aqueuse sol 1 app 2/j
pdt 7j

2 Histagan sirop 1 cac 3/j pdt 7j

3 Paracétamol 60mg/kg/j 3/j

Zona

● Éruption en bande vésiculeuse, unilatérale, douloureuse +/- fébrile

Suit le trajet d'un nerf.

⊖ Bilan : ⚡ rénal avant et après le traitement à cause de la néphrotoxicité de l'Aciclovir

1 Aciclovir cp 200mg 1cp 5/j pdt 7j

2 Eosine aqueuse sol 3app/j

3 Dolyc cp 1g 1cp 3/j

4 Neurovit B1B6 B12 cp 1cp 2/j

⊖ Si sujet jeune=> rechercher une immunodépression

■ Sérologie VIH/VHB/VHC et Glycémie à jeun

■ Enfant 🧒 :

1 Isomedine

2 Deslor

3 Doliprane

Polytraumatisme

⊗ Patient atteint au moins 2 lésions dont au moins 1 menace le pronostic vital.

⊖ Règles ABCDE en préhospitalier :

- Libérer les VAS
- Assurer l'hémostase
- Assurer l'état cardiocirculatoire
- Vérifier l'état neurologique
- Prévenir le risque d'hypothermie

☑ Mise en condition :

- Désobstruction des VAS, collier cervicale
- O2 au masque 100%
- Point de compression si besoin
- Attelle d'immobilisation
- Couverture de survie
- Inj ATB si Fractures ouvertes

 à EPH

- TA/T°/Dextro
- 2VVP
- Respecter le rachis
- Score de Glasgow
- Rx : crâne, rachis, thorax, bassin et les points d'impact
- Echographie AP
- Si hémorragie => Perfalgan ou plasma gel

Vertiges aigues

 CAT :

- O2/Dextro/TA/T°
- 1 amp Tanganil 500mg IVD
+ 1 amp Primperan diluée en IV ou IM

- TA ↗ risque AVC => TDM
- T° pas de foyer => TDM
- Céphalée + => TDM
- Bilan
- ECG
- Si signes de focalisation => Avis neurologie

- ✓ Traitement de sortie :
 - Tanganil cp 500mg 1 cp 3_5/j pdt 5j

PNA

● Inflammation transitoire du rein et de l'uretère, essentiellement d'origine bactérienne.

Fièvre, frissons, sueurs, signes fonctionnels urinaires, douleur lomboabdominale, troubles digestifs.. AEG

Signes de gravité : sepsis, Déshydratation

Signe de Giordano(+)

■ Bilan : 

■ CU (leucocytes/sang/nitrites)=> ECBU

FNS/CRP(+)/VS↗

■ Hémoculture si gravité.

■ Echographie

 Hospitalisation si :

- Age < 3 mois, uropathie
- Signes de gravité.
- Ceftriaxone 50mg/kg/j 1inj/j

■ Ou Ambulatoire :

- Cefixime 4mg/kg/12h en PO pdt 10j

Puis adapter selon AntibioGramme

- Contrôle : ECBU

Anémie férriprive

● Syndrome anémique : Pâleur, asthénie, dyspnée, Tachycardie, palpitations, troubles des phanères (ongles et cheveux cassants).

- $\downarrow$ Hb : Anémie
- $\downarrow$ Hb + $\downarrow$ VGM : Anémie par carence en fer
- $\downarrow$ Hb + $\uparrow$ VGM : Anémie par carence en B9B12
- Hb normale + $\uparrow$ VGM : hypothyroïdie

✓ Traitement selon le taux Hb :

- Hb < 7 : Transfusion sanguine
- Bilan : 
- FNS/Ferritinémie/Fer sérique
- Taux de réticulocytes

● Adulte :

- Triferfol cp 1cp/j le matin à jeun

Ou Fumafer cp 200mg

- Vit C (facilite l'absorption) cp 250mg
- Geofer amp 1amp 2/j => complément alimentaire

■ Enfant 🧒

Anémie par carence en fer touche surtout les enfants âgés de 9 à 36 mois, car ils ont épuisé, après l'âge de 6 mois.

- Supplémentaire en fer jusqu'à la normalisation de Hb au moins 2mois (4_6mois).

- Fumacur cp 2cp 2/j pdt 2mois pour corriger Hb.

Puis 4 mois pour restaurer les réserves : 1cp 2/j.

- Surveillance de taux Hb
- + traitement de l'étiologie

Ictère néonatale

● La jaunisse désigne une coloration jaune de la peau et/ou des yeux, provoquée par une augmentation du taux de bilirubine dans le sang, somnolence, mauvaise alimentation..

- Précoce : <24h
- Tardif : >7j
- Persistant >14j
- Entre J2 et J14 : ictère physiologique
- BI > 150mg/l
- BD > 20mg/l
- Si BI > 180mg/l => Exanguinotransfusion
- Nucléaire : grave due à un taux de bilirubine >200.

- Causes d'ictère physiologiques :
- Immaturité du système hépatique
- Au lait maternel bénigne mais n'arrête pas l'allaitement
- Hypothyroïdie congénitale
- Anémie hémolytique congénitale par Iso RH
Mère (-) et nn (+)
- Infection néonatale à E_choli
- Bilan :
- FNS/CRP
- Bilirubine total et conjugué
- CU
- Groupage..

 Traitement :

- Abstention et contrôle 48h
- Photothérapie
- Phénobarbital

Gastroentérite

● Douleur épigastrique + Vomissements + diarrhées

✓ Traitement :

1 Erceforyl gel 200mg 2cp 2/j

2 Spasfon cp 80mg 1cp 3/j

3 Clomperidone

+/_ Flagyl

■ Enfant 🧒 :

1 Smecta

2 Vomiteb

3 SRO

+/_ Flagyl

Appendicite

● Sensibilité douloureuse au niveau FID,
défense localisé + Fièvre +/- Vomissements

⇒ Echographie

■ TR=> douloureux

⊖ AINS sont CI

■ FNS : Hyperleucocytose

→ Orientation Chirurgie



Angiocholite

Cholécystite

1 Angiocholite :

● Douleur abdominale intense + Fièvre + ictère

⇒ Echographie

2 Cholécystite :

● Douleur de HCD + signe de Murphy (+)

irradie en bretelle vers les épaules, déclenchée par un repas copieux riche en graisses

⇒ Echographie

→ Avis Chirurgie

✓ Traitement :

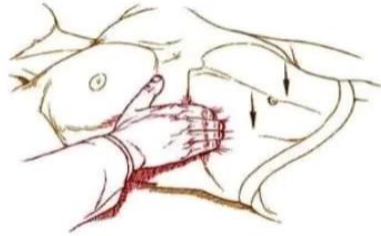
1 Clamoxyl cp 1g 1cp pdt 10j

2 Flagyl cp 500mg pdt 10j

3 Spasfon cp 80mg 1cp 2_3/j

Signe de Murphy

c'est une douleur provoquée lors d'une inspiration profonde, par la palpation sous le rebord costal droit (aire vésiculaire)
signe d'une cholécystite Aigue



Pancréatite

● Douleur épigastrique aiguë à irradiation dorsale Soulagée par l'antéflexion en chien du fusil

Anorexie, nausées, Vomissements, échy-moses, signe Gullen.

Terrain : Obèse, âgé > 80 ans

⇒ Echographie

■ TDM

■ Bilan : 

■ Lipasémie > 3N

■ TG ↗

■ ALAT ↗

■ Ca ↓

■ Bilirubine ↗

✓ CAT :Hospitalisation

- VVP

- Sonde NG si Vomissements

- Correction des troubles hydrolytiques

- Nutrition IV

Occlusion intestinale aigue

● Douleur abdominale, Vomissements, arrêt des matières et des gaz, Météorisme ou Ballonnement abdominal, défense ou contracture, orifices herniaires

Percussion : Tympanisme, matité des flancs

- ASP=> NHA
- Confirmer par une TDM
- Bilan :  pré op
- FNS : Hyperleucocytose
- TP/TCK/GLY
- Urée/Créat
- ECG
- TLT
- Ionogramme

 Orientation Chirurgie

Intoxication alimentaire

 En urgence : adulte

- Flagyl 500mg + 1amp Spasfon
+ 1amp Primperan si Vomissements

 Traitement de sortie : symptomatique

- Si fièvre : Flagyl

Ingestion de caustique

 Hospitalisation :

- Arrêt de l'alimentation orale
- Bilan d'urgence
- ASP
- TLT

 Traitement :

- Mopral 80mg 1mg/kg 2/j
- Solumedrol 60_80mg
- Réhydratation
- TDM

 Avis gastrologie

Ingestion de l'eau de javel

- ASP => si RAS
- TLT
- Réhydratation
- Mopral 1mg/kg dilué dans 200cc de SG5%
+ 0.15mg/kg de Zophren en IVL
- ☑ Traitement de sortie :
 - Antispasmodique type Timonal sirop
 - Surveillance pdt 6h

Oxyurose

● Prurit anal nocturne majoré par le grattage

Parfois vulvo vaginite chez la fille

Récidive +++

Confirmer par : scotch test le matin sur la marge anale

✓ Traitement :

■ RHD + traitement de toute la famille

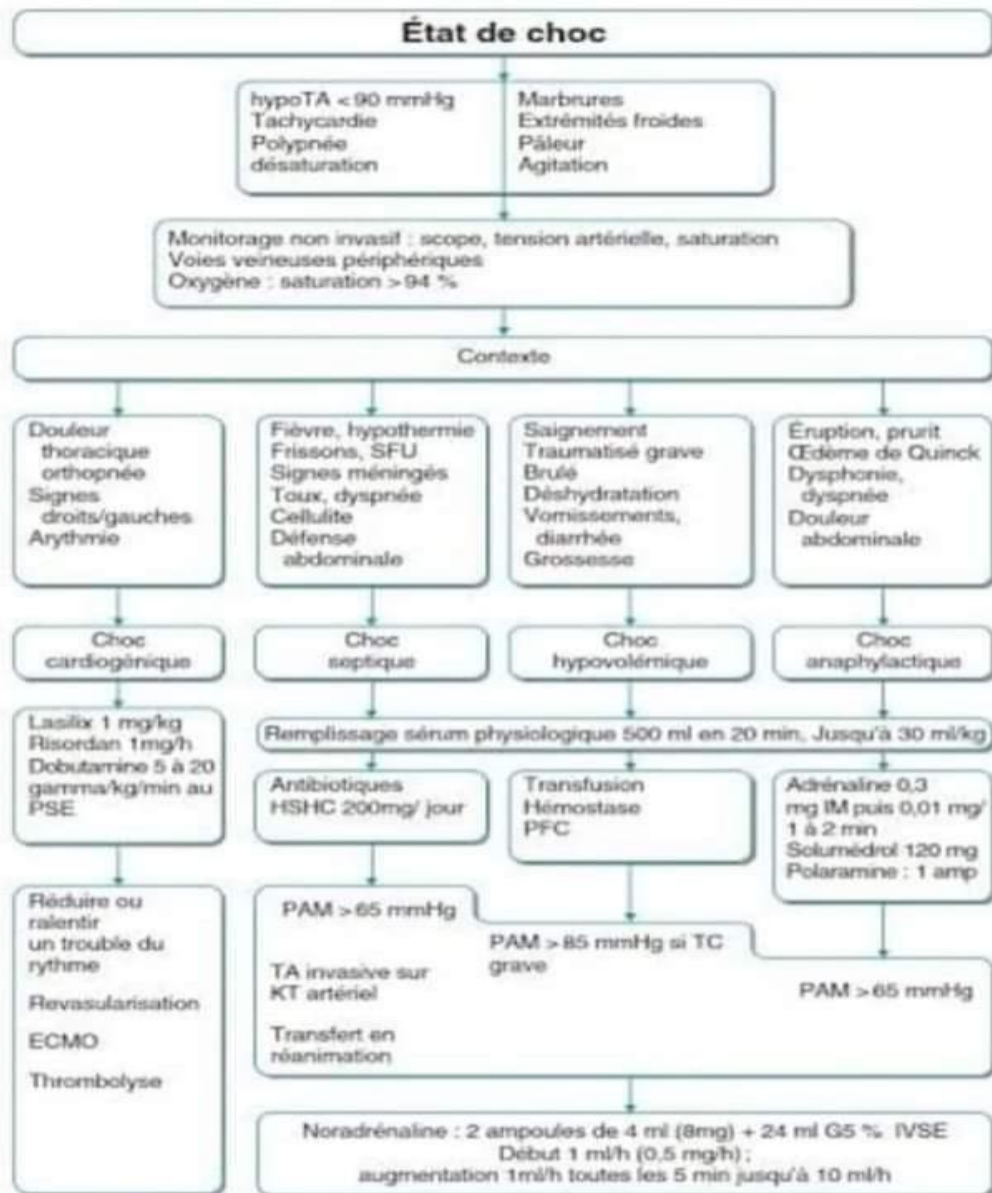
■ Couper les ongles et laver les mains.

■ Fluvermal cp/ sirop 1cac une seule prise :J1

A renouveler :J15

États de choc

Cardiogénique/Hypovolémique/Anaphylactique
/Septique



Choc Anaphylactique

● Réaction allergique aigue

Prurit, urticaire, cyanose, dyspnée+++,
sibilants,

tachycardie, hypoTA<90mmhg, puis collapsus,
œdème facial puis généralisé.

Causes: aliments, médicaments, insectes..

✓ CAT :

■ Malade en position demi assise, jambes
surélevés

■ Remplissage SS9% 500ml/24h à répéter selon
TA

+ 0.3mg Adrénaline en IM

+ CTC: 200mg HHC en IVD

■ Si dyspnée:

+ Nébulisation avec Salbutamol 5mg ou
Adrénaline 2mg dans 3cc de SS même dose que
d'une crise d'asthme

Avec O₂: 6-8l/min

Fièvre

● <2ans=> risque de Convulsion

But: ☐ 39°C

✓ CAT :

- Paracétamol suppo dose de charge 25mg/kg
+ Moyens physiques (poche de glace)
- Si pas de réponse : 12.5mg/kg après 1_2h
- Si pas de réponse : Perfalgan ($1.5 \times \text{poids} = ?\text{cc}$)
en IVL

- Si toujours $T^{\circ} > 39^{\circ}\text{C}$ => Bilan pré op
- $> 30\text{kg}$ => Paracétamol 15mg/kg IVD en perfusion
- $< 30\text{kg}$ => 12,5mg/kg

 si pas de réponse => Hospitalisation

- Bilan : 
- FNS/CRP/VS
- CU
- ECBU
- TLT
- Si RAS=> Avis pédiatrie (PL)

Conjonctivites

- Infectieuses : virale ou bactérienne (pus)

Sécrétions+++, uni puis bilatérale, sensation de sable, notion de contagé.

- Allergique :

Pas de sécrétions, bilatérale, démangeaisons, œdème, larmoiement, notion d'atopie.

● Conjonctivite bactérienne :

1 Chibroxine/Tobrex/Maxidrol collyre

2 Fucithalmic/Neomycine/Frakidex/ Sterdex/
Liposic pmd

3 Lavage oculaire Dacryosérum

- Enfant 🧒 :

1 Maxidrol/Desomedine/Chibroxine coll

2 Sterdex/Frakidex/Fucithalmic pmd

■ NRS :

1 Azyter coll 2/j pdt 3j 1 matin et 1 soir

Ou Tobrex/Desomedine/Rifamycine +

2 Fucithalmic pmd

● Conjunctivite Virale :

1 Chibroxine/Desomedine coll

2 Fucithalmic/Rifamycine pmd 1 app le soir

3 Dacryosérum 1 lavage 4/j

■ Enfant 🍼 :

■ Vitbact coll 1gtt 4/j

● Conjunctivite allergique :

1 Nabak/Naaxia/Levophta/Zalerg coll 1gtt 3/j

2 Dacryosérum 1gtt 3/j

■ Enfant 🍼 :

■ Naaxia/Levophta coll

Déshydratation aigue

● Pli cutané, yeux cernés, hypotonie, soif, perte du poids, sécheresse des muqueuses.

- Yeux cernés + fontanelle déprimée => 5%
- YC+FD+pli cutané => 8%
- YC+FD+PC+TRC => 10%
- YC+FD+PC+Fièvre ou soif => 10%
- YC+FD+PC+ troubles neurologiques => 15%

■ Ou $\left[\frac{\text{poids récent} - \text{poids now}}{\text{poids récent}} \right] \times 100 = \dots\%$

■ Bilan : 

■ Gly

■ Urée/creat

■ Ionogramme

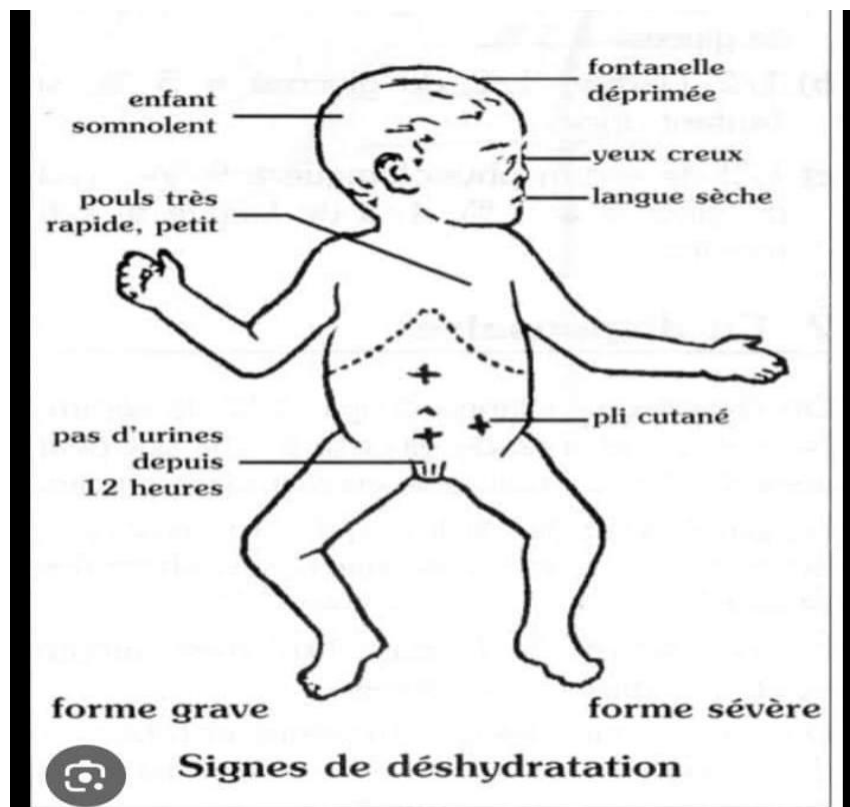
■ Ration de base :

■ 0_10kg=> 1000cc/kg/j dans 12h ÷36

■ 10_20kg=> 1000+50cc/kg ÷ 36

■ >20kg=> 1000+500+20cc/kg ÷ 36

■ Surface corporelle= $(4 \times \text{poids} + 7) / (90 + \text{poids})$



Calendrier vaccinal

Calendrier vaccinal 2023

Age Vaccin	Naissance	2mois	3mois	4mois	11mois	12mois	18mois	6ans	11-13ans	16-18ans	Tous les 10ans à partir de 18ans
BCG	BCG										
HBV	HBV										
VPO		VPO		VPO		VPO					
DTCaVPI- Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB		DTCaVPI- Hib-HVB					
PCV		PCV		PCV		PCV					
ROR					ROR		ROR				
DTCa-VPI								DTCa-VPI			
dT Adulte									dT Adulte	dT Adulte	dT Adulte

BCG: vaccin antituberculeux; HBV: vaccin anti-hépatite B; VPO: vaccin antipolio oral; VPI: vaccin antipolio injectable; DT: vaccin antidiphtérique et anti-tétanique; dT: vaccin antidiphtérique et antitétanique adulte; Ca: vaccin anticoquelucheux acellulaire; Hib: vaccin anti-*Haemophilus type b*; ROR: vaccin antirougeole, rubéole et oreillons; PCV: vaccin antipneumococcique conjugué

* Réf. Guide National de vaccination - Ministère de la Santé - 2023

Le Calendrier National de Vaccination 2023 se présente comme suit :



Âges de la vaccination	Vaccin
Naissance	BCG-HBV
2 mois	DTCaVPI-Hib-HBV + VPOb + anti pneumococcique (VPC)
4 mois	DTCaVPI-Hib-HBV + VPOb + anti pneumococcique (VPC)
11 mois	ROR
12 mois	DTCaVPI-Hib-HBV + VPOb + anti pneumococcique (VPC)
18 mois	ROR
6 ans	DTCa-VPI
11-13ans	dT
16-18 ans	dT
Tous les 1es 10 ans à partir de 18 ans	dT

II. CONCERNANT LE VACCIN COMBINE HEXAVALENT

Ce vaccin combiné sera co-administré avec le vaccin antipneumococcique conjugué et le vaccin polio par voie orale de type b (VPOb) pour la vaccination des nourrissons à l'âge de 2, 4 et 12 mois.

Le vaccin combiné combiné (DTCaVPI-Hib-HBV) est un vaccin sûr, efficace et largement utilisé dans de nombreux pays dans le Monde.

II.1. Caractéristiques du Vaccin combiné hexavalent :

- **Composition**

le vaccin combiné comportant 6 antigènes :antidiphtérique, antitétanique, anticoquelucheux acellulaire, anti-poliomyélite inactivé, anti-Haemophilus influenzae type b, et anti-hépatite B, (DTCaVPI-Hib-HBV).

- **Présentation** : Il se présente sous forme de flacon liquide monodose de 0,5 ml.
- **Co-administration** : sera co-administré avec le vaccin antipneumococciqueconjugué (VPC) dans un site d'administration différent, le VPOb étant administré par voie orale.

Maladies à déclaration obligatoire

- Brucellose
- Choléra
- Covid-19
- Diphtérie
- Fièvres typhoïdes
- Hépatite A et B
- VIH
- Leptospirose
- Listériose
- Paludisme
- Poliomyélite
- Rage
- Rougeole
- Rubéole

- Tétanos
- Toxi-infection alimentaire collective
- Tuberculose..

Maladies professionnelles

- Hémopathies
- Tétanos professionnel
- Ulcérations et dermites
- Intoxication professionnelle par les produits chimiques
- Allergies
- Affections cutanéomuqueuses
- Affections cancéreuses
- Spirochétoses
- Sulfocarbonisme professionnel
- Nystagmus professionnel
- Brucelloses professionnelles
- Ankylostomose professionnelle
- Tuberculose professionnelle

- Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels
- Hépatites virales A, B, C, D et E
- Mycoses cutanées
- Poliomyélites
- Rage professionnelle
- Affections périarticulaires
- Lésions eczématiformes
- Rhinites et asthmes professionnels
- Pneumopathies d'hypersensibilité
- Périonyxis et onyxis
- Kératoconjunctivites virales
- Pasteurelloses
- Ornithose-psittacose
- BPCO professionnelle
- Affections chroniques du rachis lombaire

Score de Glasgow

ÉCHELLE DE GLASGOW		
Bébé		
Activité	Score	Description
Ouverture des yeux	4	Spontanée
	3	À la parole ou au son
	2	À la douleur
	1	Aucune
Réponse verbale	5	Gazouille
	4	Irritable, pleure
	3	Pleure à la douleur
	2	Gémit à la douleur
	1	Aucune
Réponse motrice	6	Normale spontanée
	5	Localise à la douleur
	4	Retrait à la douleur
	3	Flexion anormale (décortication)
	2	Extension anormale (décérébration)
	1	Aucune
Enfant/Adulte		
Activité	Score	Description
Ouverture des yeux	4	Spontanée
	3	À la demande
	2	À la douleur
	1	Aucune
Réponse verbale	5	Orientée
	4	Confuse
	3	Paroles inappropriées
	2	Sons incompréhensibles
	1	Aucune
Réponse motrice	6	Obéit aux commandes
	5	Localise à la douleur
	4	Retrait à la douleur
	3	Flexion anormale (décortication)
	2	Extension anormale (décérébration)
	1	Aucune

SCORE DE GLASCOW :

Yeux : "SODA"

Spontannée (4), **O**rdre (3), **D**ouleur (2), **A**bsence (1)

Verbale : "OCACA"

Orientée (5), **C**onfuse (4), in**A**ppropriée (3),
in**C**ompréhensible (2), **A**bsente (1)

Motrice : "Oh, fleur décorative décède absolument"

Ordre (6), **FLE**xion appropriée (5), **FLE**xion
inappropriée (4), **DÉ**cortication (3),
DÉcérébration (2), **A**bsence (1)

Score de Silverman

Score de Silverman : « BB tire en geignant »			
	0	1	2
Balancement thoraco-abdominal à l'inspiration	Absent (respiration synchrone)	Thorax immobile, l'abdomen se soulève	Respiration paradoxale
Battements des ailes du nez	Absent	Modéré ou intermittent	Intense
Tirage	Absent	Intercostal discret	Intercostal + sus et sous sternal
Entonnoir xiphoïdien	Absent	Modéré	Intense
Geignement expiratoire	Absent	Perçu au stéthoscope	Audible, continu

Normale = 0/10

Gravité si $\geq 5/10$ (≥ 3 chez le grand prématuré)

Score d'APGAR

Score d'Apgar (1 min – 5 min – 10 min)

	0 point	1 point	2 points
Fréquence cardiaque	Absence de pouls	< 100/min	> 100/min
Respiration	Absente	Lente ou irrégulière	Cri vigoureux
Tonus musculaire	Faible	Flexion des membres	Mouvements actifs
Réponse aux stimuli	Absente	Grimace	Réaction vigoureuse
Coloration	Cyanose global ou pâleur	Cyanose aux extrémités	Rose généralisée

Types des certificats médicaux

- CM descriptif
- CM d'arrêt de travail
- CM justificatif
- CM de bonne santé
- CM de constat de décès
- CM d'inaptitude à la pratique du sport
- CM pour coups et blessures ...

Pathologies à dépister au milieu scolaire

- Cardiopathies (souffle aortique)
- HTA
- Dermatite atopique
- Gale
- Pédiculoses
- Psoriasis
- Diabète
- Hernie abdominale
- Maladie coéliquaue
- Oxyurose
- Hépatites
- BAV
- Nystagmus
- Otites chroniques

- Scoliose

- Asthme

- Énurésie..

Diabète

● Diagnostic :

- Glycémie à jeun=> 1.26g/l ou >7mmol/l

A 2 reprises

- HbA1c=> 6.5%

- FDR :

- Génétique

- Tabac

- Obésité : IMC>30

- Age : 40_59ans

- Grossesse

- Stress

- Types de diabète :

- Diabète T1

- Diabète T2

- Diabète gestationnel

- Complications de diabète :
- Acidocétose diabétique
- Hyperglycémie Hyperosmolaire
- Acidose lactique
- Hypoglycémie

Leishmaniose

● Vecteur : Phlébothome

✓ Traitement : Soins locaux + ATB :

- Cefacet/Flagyl

- Si 1 ou 2 lésions ailleurs que la face :

- Eau oxygénée app par compresse imbibée pdt 2min 2/j pdt 1mois

- Glucantime 2,5 cc infiltration à un 1cm de la lésion (aux 4 points cardinaux) 2/semaine pdt 1mois

- Si 3 lésions ou plus ou une lésion au niveau de la face => Hospitalisation pour un traitement par Glucantime en IM

Conduite à tenir devant Leishmaniose cutanée

- ❖ Si lésion multiple: indication de traitement par **Glucantime** par voie IM profonde.
- ❖ Si lésion unique au niveau de la face: traitement par **Glucantime** par voie IM.
- ❖ Si lésion unique au niveau des membres inférieurs: faire de infiltrations cutanées.

02cc 2x/Semaine pendant 04 semaines

Glucantime par voie IM profonde:

▪ Chez l'enfant :

$$\text{Dose ou cc} = \frac{4 \times \text{poids} \times 20}{425} = \text{dose complète}$$

- Le 1^{er} jour : 1/4 dose
- Le 2^{ème} jour : 1/2 dose
- Le 3^{ème} jour : 3/4 dose
- Le 4^{ème} jour : Dose complète pendant 10jours (tous les jours)

▪ Chez l'Adulte :

- Le 1^{er} jour : 1cc/IM
- Le 2^{ème} jour : 2 cc/IM
- Le 3^{ème} jour : 3 cc /IM
- Le 4^{ème} jour : 4cc/IM pendant 10jours (tous les jours)

NB : Les contre-indications sont :

- ✓ Chez les insuffisances rénales ; insuffisances hépatiques ; cardiopathies compliquées : l'hospitalisation est impérative.
- ✓ Chez les nourrissons de moins de 02ans : indication de l'hospitalisation.

Il faut

Faire ECG + TLT

Faire bilan CPC : NFS TP Bilan rénal, Bilan hépatique

Paludisme

● Vecteur: Anophèle femelle

Diagnostic:

Notion de fièvre après retours d'une zone d'endémie palustre <2mois.

Frissons, fièvre, sueurs.

- Non spécifique:

- Anémie/Thrombopénie/↑CRP/Cytolyse hépatique.

- Spécifique:

- Frottis mince

- Goutte épaisse

Effets secondaires des CTC

- Acné
- Cataracte
- Glaucome
- Nervosité
- Boulimie
- Vergetures
- Prise du poids
- Déminéralisation osseuse
- Retard de croissance de l'os chez l'enfant
- Augmenter le risque infectieux .

Différence entre EPH et EPSP

● Établissement public hospitalier:

regroupe au moins 4 services cliniques de base:
Chirurgie, médecine interne, Gynécologie..

- Disponibilité des spécialistes
- Hospitalisation
- PEC des urgences...

● Établissement public de santé et de proximité: polyclinique, salle des soins..

- Vaccination
- Dépistage
- Suivi des maladies chroniques
- Orientation
- Diagnostique

Complications de décubitus dorsal

- Troubles de l'élimination urinaire et Constipation
- Complications cutanées (escarres)
- Complications respiratoires
- Complications thromboemboliques

Différence entre rougeole et rubéole

■ Rougeole :

- Malaise général, irritabilité, fièvre élevée, rhinorrhée, toux..
- Rash généralisé débutant au niveau du front et rétro auriculaire, puis visage, tronc, membres.
- Disparition en 5_6j
- Maculopapuleux rouge espacées de peau saine
- Erythème des muqueuses avec dépôts blanchâtres (tâches de Koplick)

■ Rubéole :

- BEG/pas ou peu fièvre
- Arthralgies + ADP
- Eruption de visage puis tronc et membres
- Non prurigineuse s'effaçant en 3_4j
- Macules rouges ou rosacées, espacées de peau saine

Contre indications du PL

- Anomalies d'hémostase
- Thrombopénie < 50.000
- Signes cliniques d'engagement cérébral (mydriase unilatérale, hoquet, troubles ventilatoires..)
- Effet de masse sur TDM (abcès, tumeur, hémorragie)
- Instabilité hémodynamique

Classification de fracture du coude

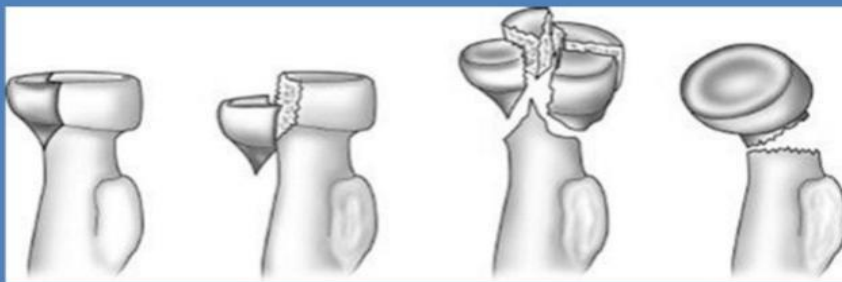
CLASSIFICATION DE MASON

Stade 1: fractures non déplacées

Stade 2 : fractures parcellaires déplacées

Stade 3 : fractures multifragmentaires

Stade 4: fracture du col rares chez les adultes



Signes de HIC

● Céphalées matinales en casque, résistantes aux antalgiques, ↑ par la toux

Vomissements en jet soulageant les céphalées

Flou visuel, HTA, bradycardie

Œdème papillaire=> atrophie puis cécité

Troubles de vigilance

Nourrisson : Macrocrânie

Yeux en coucher de soleil

Disjonction des sutures

Enfant : douleur abdominale

FO normal

✓ CAT :

- Position demi assise
- Mannitol
- CTC

Biologie de la fièvre typhoïde

- FNS: leuco neutropénie

-  Transaminases

- Certitudes: Isolement de germe

- Hémoculture

- Coproculture

- Sérologie de Widal et Félix: AC antiO/AC antiH

Allergie aux protéines de lait de vache APLV

● Poser le diagnostic :

Clinique : RGO, Vomissements, Diarrhées, ballonnements, cri inexpliqué, terrain atopique (visage rouge les joues surtout..)

■ Biologie :

■ Hypereosinophilie

■ Anémie

■ IgE total élevé

■ Hypoalbuminémie

■ Prick test+++

⇒ Lait sans PLV :

■ Pepti junior

■ Aptamil

■ Novalac riz

■ Si les signes disparaissent on confirme le diagnostic

Œil rouge

- Non douloureux sans BAV :
 - Hémorragies sous conjonctivales
 - Conjonctivites
-
- Douloureux avec BAV :
 - Crise de glaucome GFA
 - Uvéïte
 - Kératite

Brucellose

● Triade: fièvre ondulante, douleur diffuse, sueurs à odeur de paille pourrie

Consommation de produits laitiers non pasteurisés

BEG

Examen: SPM, HPM, ADP

■ FNS: leucopénies < 6000

■ CRP/VS 

■ Transaminases  $2 \times N$

■ Hémoculture

■ Sérologie de Wright

■ Traitement:

■ Cyclines

■ Aminosides

■ Rifamycine

Maladie cœliaque

● Clinique :

Diarrhées avec stéatorrhées

Douleurs abdominales

Syndrome de malabsorption

Enfant et nourrisson +++

■ Sérologie :

■ AC Antiglutaminases AGT (diagnostic et dépistage)

■ Antiendomysium AEM (Confirmation)

■ AntiDGP (test de choix)

■ Fibroscopie + Biopsie

✓ Traitement : RSG à vie

Dissection aortique

● Clinique: Douleur brutale type de déchirement, aiguë, sévère, antérieure retrosternale, pulsatile et migratrice (le long de l'aorte), souffle aortique, Asymétrie TA, Insuffisance aortique, abolition du pouls..

- ECG normal 20% si non TDR, HVG..
- TLT normal 20% si non élargissement de médiastin, double contours aortique

Aortographie

- Échographie Transthoracique
- ETO si (+)=> Angioscanner
- IRM

✓ CAT: Surveillance clinique : FC/TA

- Antalgique
- Contrôle de PA
- Traitement chirurgical

Menace d'avortement

● Clinique :

Métrorragies + Douleur pelvienne

Douleur intermittente type contractions utérines

Métrorragie : importante avec des caillots,

Écoulement de liquide amniotique

■ Examen :

■ Origine de saignement endoutérin

■ Utérus mou et $\nearrow$ ou $\searrow$ de volume par rapport à l'âge gestationnel

■ Sensibilité utérine

■ Col fermé parfois dilaté

■ Échographie

✓ CAT :

- Repos
- Ac folique
- Spasfon pour la douleur
- Progestérone inj ou intravaginale
- Si incomplet=> curetage

Menace d'accouchement prématuré MAP

● Clinique :

Contractions utérines douloureuses régulières, rapprochées

Modification cervicale de TV : col effacé, perméable..

Poche des eaux bombante ou rompue

✓ FDR :

- ATCD d'accouchement prématuré
- Grossesse multiple
- Métrorragies de T1 ou T2
- Utérus mal formé
- Poids maternel < 45kg, âgé <18 ou >35ans
- Travail pénible ou long trajet
- Grossesses rapprochées

✓ CAT :

■ Repos

 Hospitalisation si modéré ou sévère

■ Traitement étiologique : Rechercher une infection..

■ Bilan pré thérapeutique et recherche une CI à la Tocolyse : Chorioamniotite, souffrance foétale, Métrorragie importante

1 Tocolyse pdt 48h :

■ Inhibiteur calcique per os : Adalate en 1^{ère} intention

■ Antagoniste d'ocytocine : Tractocile en 2^{ème} intention

2 CTC : entre 24_34SA=> maturation pulmonaire

■ Bethamethasone 12mg 1inj en IM

A renouveler 24h après

3 Sulfate de Mg : avant 32SA si Accouchement imminent spontané ou programmé

- Dose de charge 4g puis 1g jusqu'à l'accouchement
- Progestérone (Utrogestan) avant 32SA en 2^{ème} intention
- Cerclage prophylactique si béance cervico isthmique

FDR de cancer du seins

- Puberté précoce et ménopause tardive
- Traitement hormonal substitutif de la ménopause
- Obésité
- Carence en Vit D
- Alcool Tabac
- Génétique

FDR du cancer du col utérin

- Multiparité
- Immunodépression
- Contraception orale
- Génétique
- Tabac
- Nutrition

Éclampsie

● Crises convulsives à répétition suivies d'un état comateux, aux derniers mois de grossesse, à partir de 20SA

Clinique :

- Prééclampsie sévère :

- Céphalées

- Troubles oculaires

- Troubles digestifs

+ HELLP syndrome

✓ Traitement :

- Valium + O2 thérapie au masque : 250mg en IVL

- Sulfate de Mg 4g en IVL puis 1_2g/h

- AntiHTA : Loxen 2amp et demi dans 250cc de SG ou à la seringue électrique.

HELLP syndrome

● Complication grave de la Prééclampsie, 2 ou 3ème Trimestre

Douleur épigastrique irradie vers le dos

Nausées/Vomissements, signes neurologiques..

■ Diagnostic=>biologique:

■ Thrombopénie (FNS)

■ Hémolyse(LDH)

■ Cytolyse hépatique

☑ ASAT/ALAT

ATB CI chez la femme enceinte

- Aminosides
- Cyclines sulfamides
- Quinolones
- Phénicolés
- Pyostacine, Bactrim..

Causes des hémorragies de T1

- Avortement précoce
- Mole hydatiforme
- GEU

Causes des hémorragies de T3

- Placenta prævia
- Hémorragie de Benkiser
- Hématome décidual
- Hématome rétroplacentaire
- Rupture utérine
- Rupture de cicatrice utérine
- Déhiscence de la cicatrice
- Menace d'accouchement prématuré RPM
- Hémorragies d'origine basse vulvaire, vaginale, cervicale..

Hémorragies de délivrance

● Clinique : état de choc

Utérus : mal involué, mou dépasse l'ombilic

Échographie pelvienne

✓ CAT : Réanimation :

- O2 thérapie, 2VVP, Sondage vésicale, Bilan d'urgence

- Commande du sang

- Remplissage par les macromolécules en attendant la transfusion sanguine

- Monitoring Cardio tensionnel

- Placenta non extériorisé=> Délivrance artificielle+++

- Révision utérine

- Placenta extériorisé=> Révision utérine+++

- Ocytocine + ATB
- Massage utérin
- Ocytocine 5_10ui en IM ou IVL renouvelable max 40ui
- Si échec : Perfusion de prostaglandines
- Si échec : tamponnement
- Si échec : embolisation
- Si échec : Chirurgie

Rupture prématurée des membranes RPM

 Hospitalisation :

- Repos stricte
- <34SA=> Tocolyse + Dexa pour la maturation pulmonaire
- >34SA=> attendre le travail si non déclenchement (synto)
- Bilan : FNS/CRP chaque 48h
- Surveillance foétale par ERCF

Examen de nouveau né

- Examen des yeux
- Reflexes archaïque
- Dépistage des luxations de l'épaule et de hanche
- Fontanelle
- Ictère +++
- Vomissement+++ (atrésie de l'œsophage)
- Omilic
- Émission de méconium

- Collyre
- Compresse
- Eosine aqueuse
- Si prématuré : Supplémentation en Fer, Vit D et Ca

Indications de césarienne

- ◆ Travail prolongé
- ◆ Anomalie de présentation fœtus (siège et transversale)
- ◆ Fréquence cardiaque fœtale suspecte nécessitant un accouchement rapide
- ◆ Poids fœtal >5kg
- ◆ Saignement excessif=> Hématome rétroplacentaire HRP
- ◆ Placenta prævia
- ◆ Grossesse précieuse (Primipare âgée)40ans
- ◆ Utérus bicatriciel
- ◆ Liquide teinté (souffrance fœtale)..

